

+ 医知創造ラボ

喫煙と認知症

やめても遅くない。ただし数年かかる
——減らすだけでは、下がらない

#05

監修:脳神経内科専門医

「いまさらやめても遅い」は そうではない。ただし、すぐでもない

結論

- ① 吸っている人ではリスクが高く、やめた人ではその上昇が見えなくなる。
- ② ただし下がるまでに数年かかる。3年・約7年・9年と、研究で幅がある。
- ③ 本数を減らすだけでは、禁煙と同じ利益は確認されていない。

数字を読む前に、2つだけ

 ハザード比・相対リスク=上乗せの大きさ

その人が何倍なりやすいか。95%信頼区間が1をまたぐと「差があるとは言えない」。

⚠ ここで扱うのは、すべて観察研究

たばこをやめる／やめないを割り付けた試験はない。
因果を証明したものではない。

人口寄与割合(PAF)は集団のものさし。個人が何%下がるか、という意味ではない。

■ CHAPTER 01

HOW MUCH DOES IT RISE

01

どれくらい
上がるのか

吸っている人は、約1.3倍

認知症のタイプ	現喫煙者(吸わない人と比べて)
全認知症	RR 1.30(1.18–1.45)
アルツハイマー型	1.40(1.13–1.73)
血管性認知症	1.38(1.15–1.66)

本数が多いほど高い。1日20本ごとに34%(1.34、1.25–1.43)上がる。

- 同じメタ解析の、やめた人 **ZHONG 2015, PLOS ONE**

やめた人では、上昇が見えない

認知症のタイプ	元喫煙者(吸わない人と比べて)
全認知症	RR 1.01(0.96–1.06)
アルツハイマー型	1.04(0.96–1.13)
血管性認知症	0.97(0.83–1.13)

いずれも95%信頼区間が1をまたぐ。

「上昇が確認できなかった」であって「元通りになった」ではない。

■ CHAPTER 02

HOW LONG DOES IT TAKE

02

何年で

下がるのか

■ 日本・65歳以上 12,489人 LU 2020, EUR J EPIDEMIOL

3年以上やめた人は、吸わない人と同じ水準

禁煙からの年数	ハザード比(吸わない人を1として)
現在も喫煙	1.46(1.17-1.80)
2年以下	1.39(0.96-2.01)
3～5年	1.03(0.70-1.53)
6～10年	1.04(0.74-1.45)
11～15年	1.19(0.84-1.69)
15年超	0.92(0.73-1.15)

△ きれいな右肩下がりではない。11～15年でいったん1.19に戻る。

■ 米国・32,802人／追跡中央値 9.9年 CHEN 2026, NEUROLOGY

09

低下は、約7年で頭打ちになる

⚠ この研究だけ、比べる相手が違う。基準は「吸い続けた人」。だから数字が1より小さい。前のページとは並べられない。

グループ	ハザード比(吸い続けた人を1として)
追跡中にやめた	0.84(0.73-0.95)
すでにやめていた	0.79(0.72-0.87)
一度も吸っていない	0.75(0.69-0.83)

禁煙からの年数で見ると、リスクの下がり方は約7年で平らになった。

やめた直後は、まだ高い

喫煙の状況	ハザード比(吸わない人を1として)
現在も喫煙	1.33(1.12-1.59)
最近やめた(9年未満)	1.24(1.01-1.52)
9年以上前にやめた	関連なし

「やめた直後はまだ高い」と言い切れるのは、この**1.24**(信頼区間が1を含まない)。
認知機能が下がる速さには差がなかった。

■ 3年・約7年・9年 WHY THE NUMBERS DIFFER

11

同じ問いを、違うものさしで測っている

研究	集団	比べた相手(基準)	出てきた年数
大崎	日本・65歳以上	吸わない人	3年
HRS	米国・中高年	吸い続けた人	約7年
ARIC	米国・中年から	吸わない人	9年

集団も、比べた相手も、追跡年数も、認知症の判定方法も違う。
どれか1つが正解なのではない。だから「〇年で戻る」とは言えない。

■ CHAPTER 03

REDUCING IS NOT QUITTING

03

減らすだけでは
足りない

半分に減らした人は、下がっていない

その後の吸い方	ハザード比(吸い続けた人を1として)
やめた	0.92(0.87-0.97)
半分以下に減らした	1.25(1.18-1.33)
増やした	1.12(1.06-1.18)

△「減らすと悪化する」という意味ではない。この集団は男性が95.8%。読み取れるのは「減煙では、禁煙と同じ利益は確認されていない」まで。

- 禁煙後に起きること CHEN 2026, NEUROLOGY

「頭がぼんやりする」は、観察されていない

14

🧠 禁煙直後の、一時的な認知の低下はなかった

禁煙前後で認知機能の差は認められなかった

(0.57、-0.69~1.83)。むしろ長期ではわずかに良い方向。

⚠️ ただし、体重が大きくなると見えにくくなる

5kgまでの増加では利益が保たれた。

10kgを超えると有意でなくなる(1.33、0.87-1.82)。

順番は「まず禁煙、そのあとに体重」。体重を理由に禁煙を先延ばしにしない。

- 14の危険因子で合計45% **LANCET COMMISSION 2024**

15

喫煙の PAF は 2%

× 集団のものさしでは、大きくない

第3弾の難聴は7%、第2弾のLDLコレステロールも7%だった。

「効かない」という意味ではない。

⚠ PAF は個人の確率ではない

「あなたのリスクが2%下がる」ではない。

個人では約1.3倍の上乗せがある。

小さいのは**集団への寄与**。やめた人で上昇が見えなくなる、数少ない因子でもある。

- わかっていないこと WHAT WE CANNOT SAY YET

ここから先は、まだ言えない

16

⚠ 受動喫煙

19レビュー・37メタ解析のアンブレラレビューでも、
認知症はプールした推定値が示されていない。

⚠ 加熱式たばこ

認知症をアウトカムにした研究は、
2026年8月時点のPubMed検索では見当たらない。

わからないことを「たぶん大丈夫」で埋めない。ここは空白のままにしておく。

持ち帰るのは、3つ

01

やめるのに
遅くはない

やめた人では
上昇が見えなくなる。
年齢を理由に諦めない。

02

下がるまで
数年はかかる

3年・約7年・9年。
研究で幅がある。
すぐには下がらない。

03

減らすだけでは
足りない

半分に減らしても、
禁煙と同じ利益は
確認されていない。

+ 医知創造ラボ

この動画は一般的 な情報提供です

やめ方は、次の受診で主治医に相談してください



チャンネル登録



高評価